Diskussion 377

Datum: 1920-05-11
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 6
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Carl Svensson (Socialdemokraterna, man)

1) Har herr statsrådet uppmärksamheten fästad på den svårartade utbredning, som den s. k. spanska sjukan vunnit i vissa norrländska orter, samt på den oerhörda brist på läkare och annan sjukvårdspersonal, som därunder gjort sig gällande?

2) Om så är fallet, har då icke herr statsrådet funnit dessa förhållanden påkalla omedelbara och i möjligaste mån effektiva åtgärder från de statliga hälsovårdsmyndigheternas sida för bristens avhjälpande?

3) Kan det förväntas, att, därest herr statsrådet vid ett sådant övervägande skulle för uppnående av mera tillfredsställande resultat, finna rätt till tvångstransporter av läkare och annan sjukvårdspersonal till av epidemien härjade orter oundgänglig, lagförslag därom skyndsamligen blir utarbetat och förelagt riksdagen?

Spanska sjukans härjningar i de nordligaste länen hava såsom bekant under början av innevarande år varit av synnerligen svårartad natur. Av inkomna uppgifter rörande farsotens spridning framgår, att epidemiens kraftigaste skede infallit under senare delen av februari månad. Under tiden den 15—28 febr. hava sålunda anmälda antalet fall av influensan utgjort i Västerbottens län 1,252 och i Norrbottens län 1,760. Därefter har i stort sett en stadig minskning av antalet fall ägt rum. Erfarenheten från föregående epidemier har även givit vid handen, att sjukdomens kraft i regel brytes mot sommaren. - Emellertid kunna häftiga utbrott av sjukdomen ännu förväntas å en eller annan ort.

Under ifrågavarande epidemi har givetvis behovet av läkareoch sjukvårdspersonal i de härjade orterna starkt stegrats. Rörande de åtgärder, som av medicinalstyrelsen vidtagits för att tillgodose detta behov, ber jag, med anledning av den kritik, som i detta hänseende från interpellantens sida framkommit, få återgiva följande från styrelsen inhämtade uppgifter.

Så snart »spanska sjukan» i början av året hotade, hölls inom

medicinalstyrelsen en ingående överläggning rörande sättet för bekämpande av epidemien. Därvid fastslogos de riktlinjer, som styrelsen, med hänsyn till vunnen erfarenhet från föregående epidemier av farsoten, ansåg sig böra följa för att, trots den bekymmersamma bristen på läkare och **sjuksköterskor³**, i möjligaste mån kunna bringa hjälp, där sådan vore

av nöden. I enlighet härmed riktade medicinalstyrelsen först i Läkartidningen en uppmaning till läkare och medicine kandidater att ställa sig till styrelsens förfogande för mottagande av förordnande såsom extra läkare å platser, där läkarhjälp kunde finnas behövlig. Samtidigt därmed gjorde styrelsen den 13 februari 1920 framställning till Kungl. Maj:t om höjande av arvodet för extra läkare i de norrländska distrikten till 40 kronor per dag, varjämte styrelsen anhöll om bemyndigande att inköpa instrumentuppsättningar att begagnas av de medicine kandidater, som vore villiga att åtaga sig förordnande, men som icke själva ägde erforderliga instrument. Dessa framställningar beviljades omedelbart av regeringen. Vidare vände sig styrelsen till överstyrelsen för Svenska Röda korset och till de större sjuksköterskebyråerna i landet med begäran om den hjälp för anskaffande av **sköterskor**[3], dessa institutioner kunde lämna. Dessa framställningar besvarades med utfästelser, så tillmötesgående, som omständigheterna medgåve. När sedermera tillgången på extra läkare hotade tryta, riktade medicinalstyrelsen en uppmaning till Svenska läkarsällskapet, de **kvinnliga**[1] läkarnas förening, medicinska föreningen i Stockholm samt till ett par klinikchefer i Stockholm och Lund, som handhade undervisning av äldre medicine kandidater, att medverka för anskaffande av aspiranter, till förordnande. Dessutom avläts skrivelse till Karolinska institutet, vari hemställdes, att sådana medicine kandidater, som vore villiga att mottaga förordnande såsom extra läkare under farsoten, skulle på vissa villkor få avbryta sina kurser och tjänstgöringar. Sedermera ställde styrelsen i Läkartidningen en ny uppmaning till läkarna att åtaga sig förordnande i Norrland.

Genom dessa åtgärder lyckades det styrelsen att erhålla ett betydande antal extra läkare och **sköterskor**[3]. Enligt vad medicinalstyrelsen meddelat, har styrelsen även kunnat tillmötesgå samtliga de framställningar om förordnande av extra läkare eller sköterskehjälp, som hittills gjorts från kommuners eller myndigheters sida. Sammanlagt har styrelsen utsänt 16 extra läkare i anledning av epidemien, därutav 4 till Västerbottens och 5 till Norrbottens län. Till Arvidsjaur och Arjeploug, vilka platser i Norrland torde hava varit mest utsatta för farsotens härjningar, hava genom styrelsens bemedling avsänts två, respektive tre **sköterskor**[3], flera hava ej heller besärts. Enligt vad som meddelats mig är för närvarande, sedan styrelsen hos Kungl. Maj:t utverkat höjt extra läkaroch vikariatsarvode, intet provinsialläkardistrikt i Norrland utan läkare och i vissa distrikt finnes dessutom extra epidemiläkare förordnad.

Jag ber i detta sammanhang få nämna, att Röda korset i början av mars erbjudit sig att till Norrbotten sända en ambulans, men har detta erbjudande, enligt telegram från landshövdingen i länet den

7 mars, avböjts av de kommunala myndigheterna 1 Arvidsjaur och Arjeploug, enär tillgången på läkare och sjuksystrar genom medicinalstyrelsen redan tillfredsställande ordnats och epidemien avtagit.

Det bör icke förbises, utt det i många fall för medicinalstyrelsen varit förenat med åtskilliga svårigheter att, vid den redan i vanliga fall rådande läkarbristen samt farsotens hastiga

förlopp, kunna tillmötesgå vederbörande ortsmyndigheters framställningar om läkarkrafter och sjukvårdshjälp. Till en början är att märka, att anskaffningen av läkare i stort sett måste ske på frivillighetens väg. Rätt till tvångskommendering har styrelsen allenast beträffande de civila läkarstipendiaterna. Dessa <befattningar, till antalet 25, därav 10 av första klass och 15 av andra klass, hava emellertid under senare år, trots tid efter annan förbättrade avlöningsvillkor, till största delen stått vakanta. För närvarande har styrelsen, liksom under de senaste två åren till sitt förfogande allenast en stipendiat av första klassen, vilken tjänstgör i ett vakant provinsialläkardistrikt i övre Norrland. Tidtals hava några stipendiater av andra klass kunnat erhållas, och hava dessa då befordrats till de mera svårbesättliga Norrlandsdistrikten. Vad angår de läkare, som frivilligt anmäla sig till förordnande av ifrågavarande slag, vilja dessa i regel icke binda sig för att tjänstgöra var som helst, utan förbehålla de sig vanligen att i varje fall få pröva, om de skola åtaga sig den tjänstgöring, som bjuds.

När ett telegram med begäran om extra läkare inkommer har styrelsen således först att per telegrat eller telefon söka reda på någon av de anmälda läkarna, och är någon sådan ofta icke omedelbart anträffbar. I regel är den läkare, som åtager sig förordnandet, ej heller beredd att genast avresa utan behöver han vanligen en dag till förberedelse. Sedan dröjer det kanske en eller flera dagar, innan han hinner inträffa på ort och ställe, särskilt när det är fråga om de mera avlägset belägna distrikten. I några fall har det inträffat att, sedan läkare redan avsänts. telegrafiskt återbud inkommit från den myndighet, som rekvirerat honom.

Vad **sjuksköterskorna**[3] beträffar, så torde det vara väl bekant, att ordnandet av den lokala epidemisjukvården i första hand ansetts vara en kommunal angelägenhet och att medicinalstyrelsen icke har någon som helst förfoganderätt över **sjuksköterskorna**[3]. Någon skyldighet att tillhandagå med sköterskeanskaffning åligger ej heller enligt gällande instruktion medicinalstyrelsen, utan tillkommer det i regel de lokala myndigheterna att härutinnan träffa nödiga anstalter. Under nu rådande epidemier av spanska sjukan har styrelsen emellertid, med hänsyn till de ömmande omständigheter, som förekommit i en del distrikt, och för att bringa allt det bistånd, som kunnat lämnas, varit behjälplig med anskaffandet av **sköterskor**[3]. Därvid har styrelsen givetvis varit hänvisad till frivilliga överenskommelser. I regel hava de **sköterskor**[3], som engagerats för farsotsvården, måst frånträda innehavande platser, där deras biträde för tillfället ansetts mindre nödvändigt.

Om än från medicinalstyrelsens sida sålunda energiska åtgär-

der vidtagits för att tillgodose behovet av läkarkrafter och sjuk-

k. vårdshjälp under den rådande farsoten i Norrland, kan dock å andra

sidan icke förnekas, att sjukvårdsförhållandena å vissa orter varit föga tillfredsställande. Härtill hava givetvis flera samverkande orsaker bidragit, icke minst de svåra

kommunikationsförhållandena i de glest befolkade trakter av landet, varom nu är fråga. En av orsakerna är emellertid att söka i det kända förhållandet, att tillgången på läkare och skolade **sköterskor**[3] för närvarande är otillräcklig även för normala förhållanden, en brist som givetvis gör sig starkt kännbar, när en epidemi uppträder. Det torde emellertid vara väl bekant, att ordnandet av Norrlands läkarfråga under en följd av år varit föremål för statsmakternas särskilda uppmärksamhet. Under nästan vart och ett av de senaste åren hava förslag i sådant syfte från Kungl. Maj:ts sida framlagts för riksdagen, och hava dessa förslag i huvudsak vunnit riksdagens gillande. De i anledning härav beslutade åtgärderna hava mestadels gått ut på att genom ekonomiska fördelar locka läkare att söka sig till ifrågavarande trakter. Förutom åtgärder av nu angiven natur, hava emellertid även anordningar vidtagits, vilka avsett att mera direkt ingripa för beredande av läkarvård åt befolkningen, exempelvis anställande av amhbulerande låkare. Trots alla ansträngningar ha dock Norrlands läkarfråga icke kunnat bringas till en tillfredsställande lösning, varför det lärer bliva nödvändigt att tillgripa ytterligare åtgärder för att söka uppnå detta mål. Vad sköterskefrågan beträffar, så är det att hoppas, att det nu under bildning varande distriktssköterskeväsendet skall komma att för framtiden bliva till stor nytta. Erfarenheten under senaste tid har emellertid visat, att oavsett det resultat, som genom nu nämnda åtgärder kan vinnas, särskilda åtgärder från statsmakternas sida äro påkallade för ordnande av sjukvårdsfrågan i vissa särskilt ogynnsamt ställda delar av Norrland. Jag ber få erinra, att berörda frågor helt nyligen varit föremål för överläggning inom riksdagen. Således har riksdagen med anlednig av en utav herr Bergqvist m. fl. i denna kammare väckt motion beslutat skrivelse till Kungl. Maj:t med anhållan om skyndsam utredning rörande de åtgärder, som böra vidtagas för avhjälpande av den inom de norrländska länen rådande läkarbristen. Vidare har riksdagen med anledning av en av interpellanten väckt motion beslutat hemstiälla, att Kungl. Maj:t måtte snarast möjligt låta utreda, vad som ytierligare från statens sida kan och bör göras för att bereda befolkningen i övre Norrlands fjällbygder nödig sjukvård, samt därefter vidtaga de åtgärder, vartill utredningen kan giva anledning. De sålunda ifrågasatta utredningarna har regeringen för avsikt att med det snaraste igångsätta. I samband därmed lärer jämväl det av interpellanten väckta spörsmålet angående tvångstransporter av läkare och sjukvårdspersonal till ifrågavarande trakter böra göras till föremål för övervägande. Att utan närmare utredning taga ståndpunkt till detta spörsmål, vilket givetvis för läkarkåren är av ingripande betydelse, synes mig icke möjligt, och kan jag därför för närvarande

icke i vidare mån än nu skett besvara interpellantens fråga i denna del.

2. Gustav Rosen (Frisinnade folkpartiet, man)

Herr talman! Jag ber att få till herr statsrådet framföra mitt tack för det svar, som jag erhållit på interpellationen. Det är glädjande, att det av mig framkastade spörsmålet — för övrigt ursprungligen framfört av en läkare — om tvängskomimnendering till Norrland av läkarpersonal nu skall komma upp till utredning.

I det avgivna svaret kringgås emellertid själva frågan om nödvändigheten av en organisation, som finnes tillgänglig vid epidemier av svårarare art. Det är icke mer än två år sedan, som vi

hade en den fruktansvärdaste epidemi, som på länge härjat i vårt land, och dödligheten i vissa landsdelar, särskilt i Norrland var då mycket stor. En förutseende ledning för vårt sjukvårdsväsen hade givetvis ordnat så. att vid ett eventuellt uppflammande av epidemien såväl läkare och **sjuksköterskor³** som sjukvårdsutrustning stått klara att utsändas till de platser, där epidemien uppblossade.

En läkare har sänt mig ett brev, varur jag skall be att få läsa upp följande:

»Om ett enda misstänkt fall av smittkoppor yppar sig, genast sändes en expert till platsen, vanligen åtföljd av ett medicinalråd, vilka på platsen taga reda på förhållandena och äro de lokala sjukvårdsmyndigheterna behjälpliga med att organisera försvarsåtgärderna och ordna sjukvården. Och ändock måste smittkopporna, såvitt jag förstår, för närvarande anses som en relativt ofarlig sjukdom — vi känna ju dess smittsamhet och dess symptom — gentemot denna hemska för oss okända »spanska sjuka», vilken sprider sig som en löpeld; som tar livet av unga, starka människor på till och med två dagar, som slår ned den starkaste man till en hjälplös usling, och som decimerar befolkningen på ett för staten högst beklagligt vis.» Denna läkare klandrar i skarpa ord, att man ej med den lärdom, som den förra epidemien gav oss, utarbetade en fullständig plan för epidemivård vid sådana härjande epidemier. »ÅÄtminstone kunde man som det allra minsta fordra», skriver han, »att styrelsen, då epidemien åter bröt ut, genast vidtog alla de åtgärder, som vi människor kunna tro skola göra något för att hindra spridningen och hjälpa de stackare, som insjuknat. Våra arma medmänniskor kunde då åtminstone få dö människovärdigt, ty det har många stackare ej fått göra här uppe. I mycket svåra smärtor utan möjlighet att resa ens på huvudet ha de legat i sina stugor och kojor och måst dö». Han fortsätter, att generaldirektör Buhre, då epidemien började, tillställde pressen en lugnande upplysning, att till alla orter, som velat ha läkare, ha sådana avsänts. Detta uttalande bestyrkes också i interpellationssvaret. Men han fortsätter: » Sedan epidemien härjat i mera än fjorton dagar kommer en ung oerfaren medicine kandidat: i Dorotea till och med en **kvinna¹**, och vad skall **hon²** orka. Det hade varit styrelsens enklaste skyldighet att sända hit en expert, vilken hjälpt myndigheterna att organisera sjukvården och rekvirerat hit läkare eller **sköterskor³** i tillräcklig mängd. Det

är ej möjligt annat än, att en handlingskraftig styrelse fått både läkare och **sköterskor³** hit, om den bara gjort något.»

För den militära sjukvården var det ganska väl sörjt. Epidemien härjade svårt vid de båda regementena i Umeå. Där fanns tillräckligt många läkare och **sköterskor³**, fastän de sjuka voro samlade på en plats, ty behövliga läkare kommenderades dit. Men för den civila befolkningens hjälp gick det icke an att kommendera några läkare.

När framställning ingick från ett par av epidemien härjade orter, Dorotea och Sävar, om läkarhjälp, svarade medicinalstyrelsen telegrafiskt efter ett par dagar, att ingen läkare anmält sig villig att resa dit upp!

Generaldirektör Buhres uppfattning av tvångskommendering har varit ganska växlande. Han uttalade först, att detta förslag är icke nytt, men han ansåg det omöjligt att realisera. Sedan ansåg han, att det nog icke finnes annat medel än tvångskommendering. Slutligen förklarade han, att tvångskommendering är ett invecklat spörsmål, och att en sådan lag skulle strida mot gällande uppfattning av den enskildes självbestämmelserätt. Det är alldeles riktigt, men jag har aldrig hört, att medicinalstyrelsen för egen del varit rädd att vidtaga åtgärder, som äro stridande mot den egna självbestämmelserätten, när det gäller andra!

I ett enda avseende har medicinalstyrelsen utvecklat stor energi, och det är, när det gällt att i pressen i olika artiklar genom medicinalråd och andra uttala sig på ett kanske mindre lämpligt sätt om »riksdagens njugghet» beträffande läkares avlöning och andra förmåner. Det har roat mig att taga reda på huru dåliga inkomster dessa läkare hava. Jag vill nämna vilka inkomster, tjänsteläkarna i Västerbottens län åtnjöto under år 1918 enligt deras taxering år 1919. Jag uppläser de bevillningstaxerade siffrorna, vilka äro följande: 7,300, 8,968, 9,100, 11,020, 12,360, 13,011, 15,290, 18,040, 19,149, 19,426, 19,910, 25,242, 29,996. Den sista siffran angiver inkomsten för läkaren i Vilhelmina, i den fattiga lappmarken. Förste provinsialläkaren har betydligt mindre inkomst, nämligen 12,870. Generaldirektör Buhre hade 17,360, och medicinalrådet Block, som klagar så mycket över läkarnas dåliga avlöning, hade 14,210 eller väsentligt mindre än flertalet provinsialläkare i Västerbottens län. Jag tycker, att det icke finnes något större fog för klagomålen över de dåliga inkomsterna.

Beträffande bostäderna har medicinalstyrelsen förklarat, att denna fråga måste lösas, ty annars får man inga läkare. Det finnes kommuner, Stensele och Sorsele, som ordnat denna fråga på ett förträffligt sätt. Men läkartjänsterna äro alltjämt vakanta, och mediciisen kan icke skaffa någon läkare trots att bostadsfrågan där är löst.

Jag kan icke lämna denna plats utan att till kammarens protokoll få anteckna ett par uttalanden, som visa, huru folket i de av spanska sjukan värst härjade orterna haft det under de svåraste dagarna. Diakonen Arvid Svanberg i Arjeploug har i pressen nämnt en hel del om sin erfarenhet. Jag vill taga ett litet axplock ur hans redogörelse.

Han skriver: »Jag kom sent på kvällen åkande efter häst fram till en människoboning. Hästen fastnar dock i en djup snödriva, varför jag tar min väska och knogar fram till stugan. När jag kom in, stannade jag som förstenad vid dörren. Elva personer ligga därinne i sängar och på golvet. En orerar i vildaste yrsel, en annan håller på att förblöda av näsblod, en tredje kräkes — smuts, stank och oreda omgiver dem alla. **Hustrun²** i gården, även **hon²** sjuk, skulle gå upp ech hjälpa mig, men svimmade och föll på golvet. Efter flera timmars hårt arbete kan jag lämna dem för att fortast möjligt få dit någon stadigvarande hjälp. Två unga män 1 denna familj dogo. I en annan gård, där förhållandet var nästan enahanda, dogo man och **hustru²** från sju små barn, även två av barnen dogo. I en by med omkring 30 personer lågo nästan alla sjuka — endast ett par voro uppe för att sköta både de sjuka och kreaturen. Vi gå in i en

koja långt upp mot fjälls. Det är kallt därinne och hemskt. Modern i huset ligger död och kall. Omkring **hennes²** stela kropp krypa små sjuka barn. De ropa på **henne²** och smeka **hennes²** ansikte. Nio personer av detta hushåll dogo, bland dem den kände vargdödaren Nils Skaile. I en annan ödemarksboning äro **hustrun²** och två emå barn döda. Utan hjälp ha de legat länge, då händelsevis en person kom förbi där. **Hustrun²** hade i det sista försökt att hålla sig uppe och hjälpa de övriga. Det berättas, att **hon²** sista gången hade krupit ut till ladugården för att få mjölk till barnen.» Han nämner åtskilliga sådana exempel och säger till slut: »Men tror du detta folk klagar? Nej, tysta kämpa, lida och dö de».

I Arvidsjaur sköttes sjukvården av en läkare. Slutligen fick man till denna plats ytterligare en läkare och två **sköterskor³**, som skulle hjälpa över 7,000 invånare, spridda på en areal nästan lika stor som Kristianstads län, men utan kommunikationer.

I Arjeploug fanns vid epidemiens utbrott ingen läkare. Men då epidemien slutligen var i avtagande, funnos tre läkare jämte tre **sköterskor³**, som hade att sköta över 1,000 sjuka av socknens nära 3,200 invånare. Arjeplougs areal är lika stor som Malmöhus, Hallands och Göteborgs och Bohus län tillsammans och saknar kommunikationer. Antalet dödsfall i spanska sjukan i denna socken på 3 å 4 veckor var 87, vilket utgör 2,8 4 av dess befolkning.

Nu säger man, att Arjeplougs socken avböjde den hjälp, som Röda korset erbjöd sig att lämna. Detta avböjande gjordes den 7 mars, därför att, som det uppgavs, epidemien var i avtagande. Det hade varit skäl att också nämna de villkor, som uppställdes, för att socknen skulle få denna hjälp. De voro nog sådana, att den fattiga lappmarkssocknen ej kunde antaga dem.

Trots de upprörande exemplen från Arjepluog och Arvidsjaur vidtogos likväl inga åtgärder för att möta en epidemi i angränsande socknar. På två dagar hade den spritt sig inom Sorsele socken i Västerbottens lappmark. Den utbröt där omkring den 15 mars eller något mindre än en månad efter det den utbrutit i Arjeploug. Ett par exempel härifrån torde böra nämnas. Av fyra bröder i åldern 20—30 år,

som bodde i en timmerkoja, dogo tre. I ett hem i Sorsele socken hade den av spanska sjukan angripna **hustrun²** under sjukdomen fött tvillingar. Modern dog först, så ett av de nyfödda barnen och påföljande dag dog det andra. När av en händelse en resande kom dit, lågo de tre döda kvar i rummet. Mannen låg svårt sjuk, och de överlevande småttingarna krälade omkring i rummet, där det ej kunnat tändas eld på två dagar. Denna händelse inträffade i 1 mars månad.

För läkarvården i denna socken har efter epidemiens utbrott ditsänts en läkare. Socknens areal är större än Stockholms läns, och kommunikationer saknas. Det finnes över 4,000 innevånare där. Läkaren på platsen har fått beröm för duktigt arbete, men han kunde naturligtvis icke hinna med att besöka de många sjuka i de vitt spridda byarna.

En mängd barn har under epidemien blivit faderoch moderlösa. Fattigvården i de fattiga socknarna kan ej bispringa dem, och jag ifrågasätter, huruvida det icke blir absolut nödvändigt med statliga åtgärder för deras hjälp.

Nu säger medicinalstyrelsen, att det är svårt att få tag i läkare, som vilja resa dit upp. När det kommer telegram från en socken, som begär hjälp för spanska sjukan, så gäller det att taga reda på någon läkare, som är villig att resa. Man får kanske slutligen tag i någon, och det dröjer så ytterligare några dagar, innan han kommer dit upp. Det är alldeles klart, att ett sådant förfarande icke duger, när det gäller en epidemi, som, enligt vad förste provinsialläkaren i Västerbottens län upplyst mig, går över på tre veckor. Denna tid behöver medicinalstyrelsen för att få dit upp en läkare. Det är uppenbart, att sjukvården måste organiseras, så att verksam hjälp kan sändas i samma ögonblick som en farlig epidemisk sjukdom yppar sig. Läkare, **sjuksköterskor**[3] -— och varför icke sjukvårdssoldater — sjukvårdsutrustning, m. m. böra stå färdiga till förfogande att sändas ut vart och när så påfordras.

Vidare torde det vara nödvändigt, att genom medicinalstyrelsens försorg upplysning medelas befolkningen om, huru den skall förfara, när en epidemi av denna art bryter ut, vilket den beklagligtvis icke känner till.

Det är tillfredsställande, att utredning nu skall verkställas om åtgärder för att råda bot på de missförhållanden, som jag påpekat. Men jag kan icke underlåta att förklara, att till följd av det sätt, varpå medicinalstyrelsen skött sin uppgift under denna epidemi, då den hade erfarenhet att bygga på från föregående tillfällen, nämligen 1918, det icke är mycket bevänt med det förtroende, som Norrlands befolkning hyser för denna styrelse.

3. Carl Svensson (Socialdemokraterna, man)

Med anledning av interpellantens nu havda yttrande skall jag icke gå in på någon längre debatt. Jag anser för min del i likhet med honom, att man givetvis bör ställa mycket stora krav på sjukvårdsmyndigheterna, så att de vidtaga och göra allt, vad som står i deras förmåga. Men jag tror,

att interpellanten gör sig skyldig till ett misstag, om han tror, att det kunde vara möjligt över huvud taget att skapa en sådan orgaunisation, att man skulle kunna sitta här nere i Stockholm vid en epidemis utbrott och liksom trycka på en knapp för att omedelbart därpå i dessa avlägset belägna landsdelar varom fråga är en organiserad verksamhet med tillräckligt antal läkare, **sjuksköterskor**[3] o. s. v. skulle ögonblickligen igingsättas.

Jag tror icke, att det finnes möjlighet att nå det målet, huru önskvärt det än skulle vara, och över huvud taget tror jag. att interpellanten gör sig skyldig till det misstaget att ställa alitför stora krav i detta avseende på den centrala sjukvårdsmyndigheten. Om det över huvud taget skall vara möjligt, att uti dessa trakter, varom här är fråga, åstadkomma i sjukvårdsavseende en beredskap, som är fullt betryggande, så måste det i allra högsta grad ske med tillhjälp av

därvarande lokala myndigheter. Jag syftar därvid i främsta rummet på landstingen och därnäst på kommunerna. Utan att man från deras sida tager upp denna sak på annat sätt än hittills varit fallet, tror jag icke, att man kan nå ett tillfredsställande resultat. Man får icke, det vill jag ärligen säga, sätta sig med armarna i kors och endast fordra och vänta, att från den centrala sjukvårdsmyndigheten alla åtgärder skola vidtagas. Man måste ju ha klart för sig, att det är länets och kommunens sjukvårdsmyndigheter, vilka vid epidemier i första hand måste vara rustade att på eget initiativ taga upp kampen mot sjukdomen varvid de dock naturligtvis ha rätt att påräkna allt stöd från den centrala sjukvårdsmyndighetens sida.

4. Axel Schotte (Liberala samlingspartiet, man)

Herr greve och talman! Med hänsyn till den utomordentliga vikt för övre Norrlands sjukvård, som de utav interpellanten berörda frågorna och de svar, som däråa lämnats, äga, skall jag tillåta mig yttra några ord. Jag må först säga, att jag för min del är fullt övertygad om, att medicinalstyrelsen gjort i stort sett allt vad som rimligen kunnat påfordras under ifrågavarande epidemi. Styrelsens framställningar, till Kungl. Maj:t om ökade arvoden, instrumentuppsättningar och dylikt hava också alltid beredvilligt beviljats av regeringen. Men 3 andra sidan framstår det för mig alldeles klart, att vårt svenska läkarväsende och vår sjukvårdsorganisation ej varit rustade att möta farsoten, när svåra yttre förhållanden kommit till: och det kan befaras. att så skall bliva fallet vid kommande. hotande och kanske ännu värre epidemier. Framför allt är det obestridligt. att läkareoch sjukvårdsförhållandena 1 övre Norrland ej i något avseende svara mot vad som befolkningen har rättighet att fordra och vad som är värdigt ett gammalt kulturland som Sverige.

Det kan i detta sammanhang icke ifrågakomma att närmare uttala sig om, vad som bör göras eller våga några bestämdare uttalanden om vilka åtgärder. som framför allt böra vidtagas för sjukvårdens förbättrande i Norrland. Riksdagen har ju skrivit till Kungl. Maj:t om åtgärder i detta syfte. och en utredning av dessa har också från regeringsbänken utlovats komma till stånd. Men jag vågar hysa vissa

tvivel om, att tillräckligt resultat kan förväntas med de av riksdagen i sin skrivelse lämnade direktiven. Man har enligt min mening lagt det hela för mycket på ekonomisk bog. Inkomsterna för läkarna 2 övre Norrland torde numera, såsom interpellanten för vissa delar därav påvisat, i stort sett vara någorlunda tillfredsställande. Visserligen är det sannolikt, att ytterligare en del bör göras för att ekonomiskt förbättra läkarnas i övre Norrland ställning. Särskilt spelar frågan om bättre bostäder för provinsialläkarna otvivelaktigt en viss roll. Men jag tror för min del, att läkarbristen i övre Norrland bottnar djupare än i de ekonomiska förhållandena allena.

Vår svenska läkarkår står i skicklighet och nit för sina lidande medmänniskor över all kritik; men tyvärr — det fattas här och var social samhörighet och social pliktkänsla. En viss bekvämlighetsanda har ock vunnit insteg här och var. Jag har hört läkare utmåla förhållandena i Norrland för yngre kollegor eller disciplar på ett avskräckande och överdrivet sätt, i stället för att framhålla, att tjänstgöringen däruppe visserligen är ansträngande och

helst kräver unga krafter och obruten energi, men dock i regel är tacksammare och lika lönande som längre söderut. Vad orsakerna än må vara, så stå de inre delarna av övre Norrland för närvarande nära nog utan läkare. De tillfälliga förordnanden, som skett, hava numera till stor del upphört och äro av den karaktär, att de icke avsevärt kunna inverka på läkarförhållandena i allmänhet, och särskilt när svåra epidemier hota. Största delen av övre Norrland står som sagt nästan tomt på läkare, under det läkarna i Stockholm trängas med varandra och många i hög grad få leva på hoppet att så småningom komma in bland det fåtal, som där vinner en hög vetenskaplig ställning och en omfattande praktik samt däremot svarande stora inkomster — ett hopp som ofta gäckas. Läkarens kall har enligt min mening blivit allt för fritt. Samhället bereder honom utbildning utan att fordra tillräckligt vederlag igen. Här måste, såsom interpellanten påpekar, komma ett tvång till. Frivillighetens väg har visat sig oframkomlig och kommer enligt min uppfattning att visa sig så, även med ökade ekonomiska fördelar och ökad tillströmning på läkarbanan. Detta måste man först som sist hålla i ögonen, men samtidigt leda detta tvång in på vägar, som kunna föra till målet, och som ej avskräcka, utan snarare locka till läkarbanan. Det är således givet, att med tvånget måste förenas fördelar av denna tjänstgöring i de avlägsnare delarna: goda ekonomiska villkor. särskilt av ökad tjänsteårsberäkning o. dyl. Under vad form och vilka förhållanden tvånget skall utövas, är ej nu tillfälle att vidlyftigare uttala sig om. Det gäller kanske främst att hryta den allmänna uppfattningen och opinionen inom läkarkretsar om rättmätigheten av nu rådande absoluta friheten för läkarna att bestämma. om och var och under vad form de vilja ställa till befolkningens tjänst sin av staten tillhandahållna. omfattande utbildning, och i stället framhålla den sociala plikten att verka, där nöden och lidandet är störst och behovet av läkarhjälp således mest trängande, naturligtvis inom rimliga gränser. Tvånget måste vinnas 1 sammanhang med särskilda åtgärder till mildrande av den ekonomiska tyngd,

som ett inträde på likarbanan till följd av de långa och kostsamma studierna medför. Kunske kunde man tänka sig att kombinera en atvidgning av de nu inrättade studielånen eller understöden till universitetsstudier med åtagande att efter avlagda examina tjänstgöra i. ex. ett år i inre Norrland. Civila läkarstipendieorganisationen kan säkert utvidgas och göras förmånligare, kanske ocksa sättas 1 samband med visst studieunderstöd. De nuvarande stipendiebeloppen äro utan tvivel alldeles för små, för att man med dem skall kunna påräkna en säker och alltid tillgänglig läkarreserv. En viss tjänstgöring i övre Norrlands provinsialläkardistrikt kan kanske också tänkas ingå 1 utbildninegn för vissa läkaradepter. Åtminstone förtjänar något sådant att övervägas, när det nu är fråga om en reformering av det medicinska studieväsendet. Under särskilt svåra förhållanden borde medicinalstyrelsen kunna kommendera kompetenta läkare även privatläkare, till tjänstgöring vid epidemier. Det borde ingå 1 legitimationen; och en kommendering komme naturligtvis av medicinalstyrelsen att tillämpas med all den varsamhet, som en dylik bestämmelse alltid måste kräva. Varför skulle man också icke kunna anlita de militära sjukvårdskrafterna vid trängande behov i fred av civil sjukvård? Säkerligen kunde ofta dylik kommendering av militärläkare och sjukvårdspersonal vid farsoter vara möjlig utan att militärsjukvården eftersattes och bliva till stort gagn. Utom annat lägges nu också hinder i vägen härför, genom att den militära

sjukvården organiserats under särskilda ledningar och utan att hela landets högsta centrala myndighet på området, medicinalstyrelsen, därmed har tillräckligt att skaffa. Skall en myndighet såsom medicinalstyrelsen bära ansvaret för landets sjukvård, då skall ock makten att vidtaga nödiga åtgärder härför vara koncentrerad i dess hand.

Den brist i organisationen av hela vårt sjukvårdsväsende, som i detta avseende gör sig gällande, visar sig också på ett annat område. En god del av sjukvården vid epidemier måste byggas på den hjälp, som kan lämnas genom våra sjuksköterskeorganisationer; det är då organisatoriskt och praktiskt sett menligt, att medicinalstyrelsens förfoganderätt över **sjuksk öterskorna³** är så begränsad, som den för närvarande är, och att framställningar om biträde av **sjuksköterskor³** skola bero av kommunerna och vara deras ensak. Den erforderliga hjälpen vid en epidemi måste i görligaste mån vara organiserad i förväg och med full befogenhet och myndighet ledas av den högsta centrala organisationen för landets hela sjukvårdsväsende. All villighet till hjälp torde visas av sjuksköterskeorganisationerna. av Röda korset o. s. v., men de kunna ej hava den översikt av förhållandena i landet, som kräves för ett planmässigt ordnande av sjukvården. Man fäster stora förhoppningar vid distriktssjuksköteskeorganisationen, och jag tror, att den i stort sett skall uppfylla de förhoppningarna. Intill dess distriktsköterskeinstitutionen hunnit organiseras och den nya epidemilagen fullständigt trätt i kraft, vore det emellertid av betydelse, att vederbörande tjänsteläkare eller åtminstone förste provinsialläkarne finge rätt att hos medicinalstyrelsen påkalla viss sjuksköterskehjälp vid behov, och om medicinalstyrelsen hade

rätt att kommendera **sjuksköterskor³** till dylik tjänstgöring och att kostnaden därför utginge av allmänna medel. Jag tror, att den sociala känslan och villigheten att tjänstgöra var som helst i landet är tillräckligt tillfinnandes hos **sjuksköterskorna³**. Däremot kan befaras, att bristen på sådana snart skall göra sig än kännbarare gällande än hittills, helst sedan man nu gått på ett bibehållande av den förutvarande långa utbildningstiden i stället för att nedsätta densamma, såsom på sin tid föreslagits av Kungl. Maj:t. Det är därför trängande, Just för genomförande av distriktssköterskeorganisationen, att staten får sin hand med i fråga om utbildningen av det erforderliga ökade antalet **sjuksköterskor³**; staten måste ofördröjligen sätta i gång kraftigare åtgärder än hittills för denna utbildning. Vid de utredningar angående distrikssköterskeorganisationen, som nu pågå i de norrländska länen, visar det sig sannolikt, att svårigheter i övre Norrland skola uppkomma att få just de mest behövliga distrikssköterskeplatserna besatt. En fråga, som särskilt kommer att möta åtskilliga vanskligheter vid distrikssköterskeorganisationens ordnande i övre Norrland är bostadsoch inackorderingsförhållandena i avlägsna bygder. Det är sannolikt, att staten där får träda ytterligare emellan, därest den betydelsefulla distriktssköterskeorganisationen, vad övre Norrland beträffar, skall bliva tillräckligt effektiv.

Jag tror, att från länens och de kommunala myndigheternas i Norrland sida gjorts allt, i stort sett, som kan tänkas, ja 1 Norrland t. o. m, mer än i andra trakter och mer, än vad befolkningens ekonomi i själva verket skulle tillåta. Det har byggts stora lasarett och

sjukvårdsanstalter därstädes. Vad Norrbottens län beträffar känner Jag, att det finnes en stor plan uppe för hela sjukvårdsväsendets därstädes ordnande, en plan på en organisation med ett flertal nya sjukvårdsanstalter. Enahanda är förhållandet i Västerbotten. Jag tror sålunda, att den vädjan, som herr statsrådet ställde till länen och kommunerna att kraftigt ingripa, i stort sett är fylld i förhållande till de ekonomiska möjligheter som föreligga och att överhuvud taget den plikten allt jämt skall fyllas av kommuner och landsting.

Jag vågar för min del uttala en tacksamhet till herr statsrådet, för att herr statsrådet utlovat, att den utredning angående sjukvårdsförhållandena i Norrland, som riksdagen hegärt, skall erhålla så vid ram som möjligt. Jag vågar även hoppas, att de synpunkter, som under denna debatt från olika håll kommit till synes, måtte ingå 1 den utredning, som under den närmaste tiden sålunda skall igångsättas. Jag vågar också vädja till herr statsrådet att, intill dess resultaten därav kunna förväntas, överväga vad som ytterligare och omedelbart må kunna göras för att såväl vid epidemier som i allmänhet komma Norrlands befolkning till hjälp med en sjukvård. som i någon mån motsvarar tidens krav och icke med berått mod utlämnar befolkningen nästan uteslutande till kvacksalveriets hjälp. Genom en del organisationsändringar och en del förfoganden, som redan nu kunna ske, torde det icke vara omöjligt att på organisationens väg vinna förbättringar, även om naturligtvis för ett mera fullständigt ordnande av förhållandena den utredning. som är utlovad, måste avvaktas.

5. Gustav Rosen (Frisinnade folkpartiet, man)

Jag blev något överraskad av att herr statsrår det uttalat så bestämt, att han icke trodde, att staten skulle kunna ordna sjukvårdsorganisationen så, att den kunde användas genast vid inträdande epidemier. Jag trodde annars, att det alldeles särskilt skulle intressera herr statsrådet att staten skulle göra det.

Det är ju så, att vid mobilisering ringer icke vederbörande sjukvårdsledning på till läkarne och frågar, om de vilja resa, utan de kommenderas helt enkelt att resa till den plats, som bestämmes uv ledningen. Jag tror, att det kan vara lika angeläget att förfara pi samma sätt, när det gäller en sådan farsot som den, vilken nyss gått över Norrland. Det är nämligen inga bagateller, som det här är fråga om, ty om antalet dödsfall i hela riket skulle varit lika stort som i Arjeploug, skulle över 165,000 personer i hela landet hava dött på tre eller fyra veckor. Jag tycker, att det är en ganska allvarlig sak, som man nog får söka anstränga sig att göra något för.

Jag beklagar, att herr statsrådet är av den uppfattningen, att kommunerna och landstingen i Norrland hava suttit med armarna i kors, när det gällt sjukvården. Jag vill med anledning av herr Schottes uttalande säga, att Västerbottens län under en följd av år varit det mest skattetyngda landstingsområdet i riket just på grund av sina omfattande sjukvårdsåtgärder. Man har hittills icke sparat, när det gällt sjukvårdsanstalter, och för närvarande har man anslagit eller måste ytterligare anslå belopp av 4 till 5 miljoner kronor för sådana anstalter, vilka skola komma till utförande, och då tycker jag icke, att det finns någon anledning att tala om, att man sitter med armarna 1 kors.

6. Alfred Petren (Socialdemokraterna, man)

Herr talman, mina herrar! Interpellanten har i sitt klander över medicinalstyrelsens enligt hans mening bristande åtgärder i denna fråga synbarligen utgått ifrån, att medicinalstyrelsen hade i sin makt att skaffa och skicka så mycket **sjuksköterskor³** som helst till Norrland vid "denna epidemi. Men som ju för övrigt herr statsrådet och chefen för civildepartementet redan påpekat, har medicinalstyrelsen icke någon sådan befogenhet, ty det är ju så, att **sjuksköterskorna³** icke avlönas av staten, utan att detta är en kommunal angelägenhet. Man kan alltså icke skicka **sköterskor³** med mindre än att kommunerna begära att få sådana. Denna fråga måste alltså ses från mer än en sida. Frågan är icke endast den: har medicinalstyrelsen tillräckligt hastigt skaffat vad som begärts i fråga om **sköterskor³**?

Man måste också göra en annan fråga, nämligen den: hava kommunerna i tid tagit det innitiativ, som varit av behovet påkallat? Det har här mycket talats om Arjeploug, som hade det särskilt svårt under epidemien. Jag kan då nämna, att enligt upplysning av den första sändning, som kom dit, bestående av en läkare och ett par **sköterskor³**, påyrkade dessa, att kommunen skulle rekvirera flera **sköterskor³**, men till en början ställde sig kommunen avvisande, och först en vecka senare, när sjukdomen var på retur, telegraferade kommunalordföranden äntligen efter flera läkare och **sköterskor³**. En läka-

re och ett par **sköterskor³** blevo i anledning härav också ytterligare ditsända. Detta är alltså en synpunkt, som vi icke få glömma, att det nämligen är kommunerna, som ha att rekvirera **sköterskorna³**, tv, som det nu är, är det kommunerna, som ha att betala dem.

Sedan riksdagen emellertid nu beslutat om statsbidrag till anställande av distriktssköterskor, kan man ju hoppas, att landsbygdens sjuksköterskeväsen snart skall komma att ordnas, och sedan bli ju förhållandena helt annorlunda än de för närvarande äro.

Man har vidare här talat om att det enda sättet att få läkare till övre Norrland vore att tillgripa tvångskommendering av läkare. Vi hava ju nu hört av herr statsrådet, att även denna fråga kommer att tagas under övervägande vid den av riksdagen begärda utredningen rörande ordnandet av läkareförhållandena i Norrland. För min del måste jag säga, att det hos mig väcker rätt stora betänkligheter att i fråga om ett arbete av så rent personlig art som läkarnas och **sköterskornas³** tillgripa tvångskommendering. När civilläkarstipendiatinstitutionen infördes, var avsikten härmed, att dessa läkarstipendiater skulle mottaga förordnanden, där medicinalstyrelsen bestämde. I deras skyldigheter ingick alltså även att mottaga en tvångskommendering. Nu är det ju så, att hela denna institution på senare tiden blivit till ingen nytta, när inga sökande anmält sig till dessa stipendier. Såsom herr Schotte framhöll, böra förbättringar vidtagas i dessa stipendiaters villkor, så att befattningarna kunna besättas. Jag tror också, att det är den riktiga vägen att gå, att man söker få till stånd en kår av läkare, i vilkas skyldighet det ingår att mottaga tvångskommendering mot vissa förmåner — att de sålunda mot erhållande av sådana förmåner förbinda sig att mottaga tvångskommendering. Den ersättning, som ifrågavarande stipendiater för närvarande åtnjuta för att stå till

medicinalstyrelsens förfogande, är ju endast 2,500 kronor om året utan dyrtidstillägg, och det är klart, att detta med nuvarande penningvärde är alldeles för liten ersättning för skyldigheten att underkasta sig tvångskommendering. Det är kanske också en väl lång tid, för vilken civilläkarstipendiaterna nu äro tvungna att binda sig, nämligen tre år. Tiden härför har redan en gång sänkts från fem år, som var det ursprungliga. till tre år, och det kan som sagt ifrågasättas, om den icke borde ytterligare förkortas. Ty det ligger ju i sakens natur, att det skulle vara lättare att få stipendiater, om den tid, för vilken de skulle förbinda sig att stå till förfogande, för tjänstgöring om så påfordrades icke vore så lång.

Önskvärt vore naturligtvis att kunna få läkardistrikten uppe i Norrland besatta med ordinarie innehavare. Det har framhållits av medicinalstyrelsen, att det för att nå detta mål är nödvändigt att ordna dessa befattningshavares ekonomiska förhållanden på ett bättre sätt än hittills. Här har nu av interpellanten och även av den andre talaren på Västerbottensbänken, sagts, att man härvidlag alltför mycket lagt tyngdpunkten på de ekonomiska synpunkterna. Särskilt har interpellanten anfört siffror rörande provinsialläkarna i Västerbottens län inkomster, vilka efter hans mening, om jag fattade honom rätt, skulle visa, att det är väl beställt i detta avseende. Av de upplysnin-

gar han lämnade framgår, att åtskilliga av ifrågavarande läkare i Västerbottens län hava relativt goda inkomster — bortåt 20.000 kronor om året, undantagsvis t. o. m. något däröver. Men det fanns också åtskilliga av dessa läkare, vilkas inkomster icke gått upp till 15,000 kronor, ja stannat under 10,000 kronor, och i något fall vid 7,000—38,000 kronor. Då man talar om läkares inkomster, måste man taga med i beräkningen, att läkarnas utbildningstid är avsevärt lång 1 regel nio å tio år. Den som icke i sig själv haft någon förmögenhet, har därför i allmänhet icke kunnat fullfölja sina studier under en 20,900 kronors skuld för sin utbildning. En så stor och än större skuld är bland nyutexaminerade läkare ingenting ovanligt. Vid beräknandet av behovet av inkomster för läkarna, har man därför också att räkna med ränta och amortering på denna skuld. Från inkomsten har man alltså först att draga ett par tusen kronor för dessa utgifter. Därtill kommer en annan omständighet, som gör att tjänstemän, som äro bosatta i Norrland, gärna behöva relativt bättre inkomster än många andra, och det är, att om de vilja att deras barn skola få en bättre skolutbildning än den som kan lämnas av ortens skolor, det är förenat med stora kostnader, då de i så fall måste ha sina barn inackorderade i städer på långt avstånd från hemorten, och inackorderingsavgifterna hava ju för övrigt, som vi veta, under de sista åren stigit enormt. Detta är också en synpunkt, som man har att taga i betraktande. Jag tror därför icke, att man kan säga, att de ekonomiska förhållandena för alla läkare uppe i Norrland äro tillfredsställande ordnade.

Men naturligtvis är det icke endast de ekonomiska förhållandena, som det är av vikt att ordna för Norrlandsläkarna. En fråga som det, efter vad som framhållits av läkare, vilka känna förhållandena i Norrland, är av stor vikt att ordna är bostadsfrågan. Det har också framhållits av provinsialläkarkommittén, att det är av mycket stor vikt, att läkarna där uppe, vilka hittills ofta haft mycket dåliga bostadsförhållanden, få ordentliga bostäder, då det hur än

löneförhållandena bli ordnade, icke är någon förhoppning om att få dessa tjänster besatta, förrän bostadsförhållandena blivit ordnade på ett tillfredsställande sätt.

En annan fördel, som ju också lämpligen borde beredas tjänsteläkarna uppe i övre Norrland, berördes av herr Schotte, nämligen att tjänstgöringen där medförde förhöjd tjänstårsberäkning eller i varje fall finge karaktären av att vara mera meriterande, så att den tid, som läkarna behöva stanna där uppe, innan de få transport, icke bleve alltför lång.

Jag är övertygad om, herr talman, att den riktiga vägen är att söka bereda läkarna uppe i ödemarkerna bättre förmåner i olika riktningar än andra läkare. Jag tror, att detta är det bästa sättet att verkligen få läkare till dessa trakter.